

Exantemas virales clásicos (sarampión, rubéola, varicela, escarlatina)

1. Introducción y relevancia clínica

Los **exantemas virales** son uno de los **motivos de consulta más frecuentes en pediatría**, especialmente durante la infancia y en contextos de brotes epidémicos.

El reconocimiento clínico de sus patrones es clave para el **diagnóstico diferencial**, las **medidas de aislamiento y la notificación obligatoria**, según el **Reglamento Sanitario Internacional y las normativas del MINSAL**.

Entre los **exantemas clásicos**, los más relevantes en Chile son:

1. **Sarampión**,
2. **Rubéola**,
3. **Varicela**,
4. **Escarlatina** (de origen bacteriano, por *Streptococcus pyogenes*).

El correcto reconocimiento de estos cuadros es esencial para el manejo clínico y la vigilancia epidemiológica, ya que **sarampión y rubéola son enfermedades de notificación inmediata**, con programas nacionales de erradicación.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

Un **exantema** es una **erupción cutánea generalizada aguda** asociada a infección, usualmente viral.

Su fisiopatología incluye:

- **Respuesta inmunológica sistémica** frente a virus o toxinas bacterianas.
- **Lesión directa del endotelio o epitelio cutáneo**.
- **Deposición inmune y liberación de citoquinas** (vasodilatación, extravasación).

Las manifestaciones exantemáticas reflejan la **replicación viral sistémica y la respuesta inmune del huésped**.

3. Principales exantemas clásicos

A continuación, se presenta el resumen comparativo de los cuatro cuadros principales evaluados en EUNACOM:



1. Sarampión (Morbillivirus, Paramyxoviridae)

a.

Epidemiología y transmisión

- Muy contagioso (90 % de susceptibles expuestos).
- Transmisión: **aérea por gotitas y aerosoles.**
- Período de contagio: **4 días antes y 4 días después del exantema.**

b.

Clínica

- **Pródromo (3–4 días):** fiebre alta, tos, coriza, conjuntivitis (las 3 C).
- **Signo de Koplik:** puntos blanquecinos en mucosa yugal, patognomónicos.
- **Exantema:** máculo-papular, comienza en cara (retroauricular), progresa a tronco y extremidades, **respeta palmas y plantas**, desaparece en igual orden.
- Fiebre persiste durante la erupción.

c.

Complicaciones

- Otitis media, neumonía, encefalitis (1/1000).
- Panencefalitis esclerosante subaguda (rara, años después).

d.

Prevención

- **Vacuna SRP (sarampión, rubéola, parotiditis):**
 - 1ª dosis: 12 meses,
 - 2ª dosis: 1º básico (6 años).
- Brotes → campañas de refuerzo.
- Notificación obligatoria y aislamiento respiratorio.

□ En EUNACOM: “Fiebre alta, tos, conjuntivitis, signo de Koplik y exantema descendente → sarampión.”

□

2. Rubéola (Rubivirus, Togaviridae)

a.

Transmisión y epidemiología

- Contagio respiratorio.
- Menos contagiosa que el sarampión.
- Período de incubación: 14–21 días.

b.

Clínica

- Cuadro leve o incluso asintomático.
- **Linfadenopatías retroauriculares, suboccipitales y cervicales posteriores** (muy características).
- Exantema rosado fino, inicia en cara y se disemina rápidamente a tronco y extremidades, **desaparece en 3 días sin descamación** (“enfermedad de los 3 días”).
- Fiebre baja o ausente.

- Artralgias o artritis transitoria en adolescentes.

c.

Complicaciones

- **Síndrome de rubéola congénita (SRC):** infección intrauterina → sordera, cardiopatías, cataratas, microcefalia.
- Mayor riesgo si infección en primer trimestre.

d.

Prevención

- **Vacuna SRP**, igual que para sarampión.
- Evitar embarazo dentro de 4 semanas tras vacunación.

☐ En EUNACOM: “Niño con adenopatías retroauriculares y exantema rosado de 3 días → rubéola.”

☐

3. Varicela (Virus varicela-zóster, Herpesviridae)

a.

Transmisión

- Aérea o por contacto directo con vesículas.
- Muy contagiosa: 1–2 días antes del exantema hasta que todas las lesiones estén en costra.

b.

Clínica

- Fiebre moderada, malestar general.
- **Exantema vesicular polimorfo** (“en distintos estadios”): máculas → pápulas → vesículas (“gota de rocío sobre pétalo de rosa”) → pústulas → costras.

- Predomina en tronco y cuero cabelludo, respeta palmas y plantas.
- Pruriginosa.

c.

Complicaciones

- **Sobreinfección bacteriana** (impétigo, celulitis).
- Neumonía varicelosa, cerebelitis, encefalitis (raras).
- Riesgo severo en inmunocomprometidos y recién nacidos.

d.

Tratamiento

- Sintomático (antipiréticos, higiene cutánea).
- **Evitar AAS (riesgo de síndrome de Reye).**
- **Aciclovir** en:
 - Inmunodeprimidos.
 - Adolescentes >13 años.
 - Casos graves o con enfermedad cutánea crónica.

e.

Prevención

- **Vacuna antivariela:**
 - 1ª dosis: 18 meses.
 - 2ª dosis: 1º básico (6 años).
- Aislamiento domiciliario hasta costras.

☐ En EUNACOM: "Exantema vesicular pruriginoso con lesiones en distinto estadio evolutivo
→ varicela."



4. Escarlatina (bacteriana, *Streptococcus pyogenes* grupo A)

a.

Fisiopatología

- Exotoxina eritrogénica liberada por cepas lisogénicas de *S. pyogenes*.
- Es, por tanto, una **reacción toxigénica**, no una viremia.

b.

Clínica

- Inicio agudo con fiebre alta, odinofagia intensa, vómitos.
- Exantema **eritematoso difuso tipo “papel de lija”**, más intenso en pliegues (**líneas de Pastia**).
- Lengua aframbuesada (“en fresa”).
- Palidez peribucal característica.
- Descamación al resolverse (3–5 días).

c.

Diagnóstico

- Clínico + test rápido o cultivo faríngeo para *S. pyogenes*.

d.

Tratamiento

- **Penicilina benzatina** IM dosis única o amoxicilina VO 10 días.
- Evitar complicaciones post-estreptocócicas (fiebre reumática, glomerulonefritis).

☐ En EUNACOM: “Niño con fiebre, faringoamigdalitis y exantema tipo papel de lija → escarlatina.”

4. Diagnóstico diferencial general de exantemas febriles

Característica	Sarampión	Rubéola	Varicela	Escarlatina
Agente	Morbillivirus	Rubivirus	VZV	<i>S. pyogenes</i>
Pródromo	Tos, coriza, conjuntivitis	Adenopatías	Fiebre y malestar	Fiebre, odinofagia
Tipo de exantema	Máculo-papular, confluyente	Fino, rosado, fugaz	Vesicular polimorfo	Eritematoso, áspero
Distribución	Cara → tronco	Cara → tronco	Tronco → extremidades	Difuso, pliegues
Otros signos	Koplik, fiebre alta	Adenopatías retroauriculares	Lesiones en distinto estadio	Lengua aframbuesada
Vacuna	SRP	SRP	Varicela	No (bacteriano)

5. Complicaciones y pronóstico

Enfermedad	Complicaciones	Pronóstico
Sarampión	Neumonía, encefalitis, panencefalitis	Mortalidad 1/1000
Rubéola	Rubéola congénita	Benigno en niño sano

Varicela	Infecciones secundarias, cerebelitis	Excelente en inmunocompetentes
-----------------	--------------------------------------	--------------------------------

Escarlatina	Fiebre reumática, glomerulonefritis	Excelente con antibióticos
--------------------	-------------------------------------	----------------------------

6. Prevención y control (según MINSAL 2024)

- **Notificación obligatoria inmediata:** sarampión y rubéola.
- **Aislamiento respiratorio:** sarampión, varicela.
- **Vacunación universal:**
 - **SRP:** 12 meses y 6 años.
 - **Varicela:** 18 meses y 6 años.
- **Antibióticos (escarlatina):** cortan contagio en 24 h.
- **Postexposición:**
 - SRP en contactos susceptibles dentro de 72 h.
 - Inmunoglobulina antivaricela en inmunodeprimidos expuestos.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

☐ Perlas:

1. **Sarampión:** fiebre + tos + conjuntivitis + Koplik + exantema descendente.
2. **Rubéola:** adenopatías retroauriculares + exantema rosado de 3 días.
3. **Varicela:** vesículas en diferentes etapas evolutivas, pruriginosas.
4. **Escarlatina:** exantema tipo “papel de lija” + lengua aframbuesada.

5. **Vacuna SRP protege contra sarampión y rubéola (y parotiditis).**
6. **Antibióticos solo en escarlatina.**
7. **Aislamiento hasta resolución completa de lesiones.**

□ **Errores frecuentes:**

- Confundir exantema variceloso con enterovirus.
 - Usar aspirina en varicela (riesgo de síndrome de Reye).
 - No notificar sarampión/rubéola sospechosos.
 - Diagnosticar escarlatina sin confirmar *S. pyogenes*.
 - Omitir vacuna de refuerzo SRP en escolares.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **Exantemas clásicos:** sarampión, rubéola, varicela, escarlatina.
2. **Sarampión:** fiebre alta + Koplik + exantema descendente.
3. **Rubéola:** adenopatías retroauriculares + exantema leve de 3 días.
4. **Varicela:** vesículas en distinto estadio, pruriginosas.
5. **Escarlatina:** faringoamigdalitis + exantema áspero + lengua aframbuesada.
6. **Vacuna SRP y varicela previenen los principales exantemas.**
7. **Notificación inmediata:** sarampión y rubéola (brotes controlados en Chile).